

FICHA TÉCNICA CLÍNICA: YBOCS

1. Identificación del Instrumento

Título original	Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS)
Título español	Escala de Obsesiones y Compulsiones de Yale-Brown
Sigla	Y-BOCS
Autores originales	Wayne K. Goodman, L. H. Price et al.
Año original	1989
Adaptador español	Sal y Rosas, et al. / CIBERSAM / Inchausti et al.
Año adaptación	2002 / 2014
Formato	Escala de heteroevaluación clínica o autoinforme (Y-BOCS-SR) de 10 ítems

2. Fundamentación Conceptual y Teórica

La Y-BOCS fue diseñada como una escala clínica específica para medir la severidad de los síntomas del Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC), enfocándose en la interferencia, el tiempo consumido, el malestar y el control, independientemente del tipo o contenido concreto de las obsesiones y compulsiones del paciente.

3. Características Generales

Objetivo	Cuantificar la gravedad clínica general del Trastorno Obsesivo-Compulsivo.
Población	Adultos con diagnóstico o sospecha clínica de TOC.
Administración	Entrevista clínica estructurada o autoadministrado (SR) (aprox. 15 minutos).
Tiempo	Aproximadamente 15 minutos.
Corrección	Suma de los 5 ítems de obsesiones y los 5 ítems de compulsiones (rango total: 0-40).

4. Estructura y Dimensiones

Dimensión / Factor	Ítems	Invertidos	Descripción
Subescala de Obsesiones	Ítems 1 al 5 (Tiempo, interferencia, distress, resistencia, control)	No	Evalúa la gravedad clínica de las intrusiones cognitivas obsesivas.
Subescala de Compulsiones	Ítems 6 al 10 (Tiempo, interferencia, distress, resistencia, control)	No	Evalúa la gravedad clínica de los rituales conductuales compulsivos.

5. Sistema de Puntuación

Cada uno de los 10 ítems se responde en una escala de severidad de 0 (Ninguno) a 4 (Extremo). La puntuación total se calcula sumando todos los reactivos, con un rango posible de 0 a 40 puntos.

6. Interpretación de Resultados y Baremos

La puntuación total de la Y-BOCS se interpreta de la siguiente manera:

- 0 - 7 puntos: Síntomas subclínicos.
- 8 - 15 puntos: TOC leve.
- 16 - 23 puntos: TOC moderado (corte de relevancia clínica).
- 24 - 31 puntos: TOC grave.
- 32 - 40 puntos: TOC extremo.

7. Evidencia Psicométrica (Confiabilidad y Validez)

La Y-BOCS cuenta con una consistencia interna sobresaliente (Alfa de Cronbach > 0.89) y una altísima fiabilidad interjueces ($r > 0.90$) en ensayos clínicos oficiales.

8. Adaptaciones y Validaciones en Español

La versión autoinformada (Y-BOCS-SR) y las entrevistas estructuradas adaptadas al español por Sal y Rosas et al. (2002) demuestran cualidades métricas excelentes equivalentes al original en inglés.

9. Aplicaciones Prácticas

Investigación farmacológica del TOC, monitoreo de la terapia conductual (EPR) y clínicas de salud mental especializadas.

10. Fortalezas del Instrumento

- Es el estándar de oro clínico e internacional para medir la severidad del TOC.
- Evalúa los parámetros funcionales del trastorno con independencia del tipo de síntoma.

11. Limitaciones Clínicas y Metodológicas

- Requiere un listado de síntomas previo como punto de referencia para su validez constructiva.

12. Consideraciones Éticas y Legales

Debe aplicarse aclarando de antemano el carácter de las obsesiones para evitar la resistencia o culpa del paciente.

13. Síntesis Técnica General

La Y-BOCS es el estándar de oro clínico absoluto e internacional para evaluar la severidad y evolución del Trastorno Obsesivo-Compulsivo.

14. Referencias Bibliográficas (APA 7)

- Goodman, W. K., et al. (1989). The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. I. Development, use, and reliability. *Archives of General Psychiatry*, 46(11), 1006-1011.
- Sal y Rosas, et al. (2002). Propiedades psicométricas de la escala Y-BOCS en pacientes españoles. *Revista de Psiquiatría y Salud Mental*.